

Un patient de 67 ans se présente avec un état fébrile et une asthénie. Il s'est fait traité pendant 10 jours par antibiotique par son médecin traitant pour une pneumonie il y a 2 semaines. Vous réalisez une radiographie du thorax qui montre un épanchement pleural gauche. A quel diagnostic pensez-vous?

This is a multiple-choice survey.

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://plago-clinique.de/889311>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:36:05 +0200

participants: 0 | time left: 1:51

Options:

- ☐ Tuberculose pulmonaire
- ☐ Cancer pulmonaire avec carcinose pleurale
- ☐ Emypème
- ☐ Insuffisance cardiaque

Vous traitez un patient aux urgences pour un traumatisme. Sur le scanner thoraco-abdominal vous découvrez un nodule pulmonaire isolé du lobe supérieur droit de 8 mm. Quels seront les éléments importants pour la suite de la prise en charge? 

This is a multiple-choice survey.

This survey is . People can access this survey at <https://www.surveymonkey.com/s/889311>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:37:48 +0200.

participants: 0 | time left: 0:49

Options:

- ☐ La présence d'un tabagisme
- ☐ La taille du nodule
- ☐ L'âge du patient
- ☐ L'aspect du nodule

results (%)

Une patiente de 27 ans, en bonne santé habituelle, se présente avec un pneumothorax spontané. Quelles questions feront partie de votre anamnèse? 

This is a multiple-choice survey.

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://p122r.cu42148.ca/863111>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:39:27 +0200.

participants: 0 | time left: 0:58

Options:

- ☐ Est-ce que vous fumez?
- ☐ Est-ce qu'il existe des cancers ou des kystes du rein dans la famille?
- ☐ Est-ce que vous êtes en période de menstruation?
- ☐ Est-ce que c'est la première fois que cela vous arrive?

4

results (%)

Parmis les principes de base du drainage pleural, lequel est faux ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://p13hp3-p146.ctm.com/1430112>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:44:22 +0200

participants: 0 | time left: 0:52

Options:

- ☐ Un dispositif anti-retour est systématique
- ☐ Le drain est clampé lors du transport du malade
- ☐ Le drain peut être en aspiration ou en décive
- ☐ Un drain en aspiration bien positionné dans l'espace pleural peut ne pas buller
- ☐ Un drain doit systématiquement être accompagné d'un traitement antalgique adapté

results (%)

Pour un cancer pulmonaire débutant (stade I) le traitement de 1er choix est: 

This survey is **running**. People can access this survey at <https://plato.openstax.org/s/569522>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:47:32 +0200.

participants: 0 | time left: 0:58

Options:

- ☐ Une résection chirurgicale atypique (wedge)
- ☐ Une radiothérapie stéréotaxique
- ☐ Une résection anatomique (lobectomie ou segmentectomie)
- ☐ Une chimiothérapie
- ☐ Toutes ces réponses sont justes



Pour le staging d'un cancer pulmonaire il faut avoir au minimum

This is a multiple-choice survey.

This survey is  People can access this survey at [https://www.surveymonkey.com/r/1234567890](#)
end of survey: Tue, 10 Jun 2024 12:51:40+0200

participants: 0 | time left: 0:51

Options:

- ☐ PET-CT
- ☐ IRM cérébrale
- ☐ EBUS
- ☐ CT thoraco-abdominal injecté

Sont utiles pour stratifier le risque opératoire pour une résection pulmonaire

This is a multiple-choice survey.

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://forms.gle/5G4X5G4X5G4X5G4X>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:01:08 +0200

participants: 0 | time left: 0:53

Options:

- ☐ Capacité de diffusion DLCo
- ☐ Volume résiduel VR
- ☐ Volume expiratoire maximal par seconde VEMS
- ☐ Consommation maximale d'oxygène VO_2max

Vous recevez aux urgences un patient de 43 ans, ancien toxicomane, connu pour un aspergillome à l'apex pulmonaire droit, avec une hémoptysie. Quand vous entrez le boxe, le patient est un train de remplir un haricot de sang frais. Qu'est-ce que vous faites en priorité: 

This survey is  People can access this survey at <https://pingo.qualtrics.com/jfe/form/SV59112>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:05:01 +0200

participants: 0 | time left: 0:58

Options:

- ☐ Avertir les radiologues interventionnels
- ☐ Intuber le patient
- ☐ Positionner le patient sur son côté droit
- ☐ Positionner le patient sur son côté gauche
- ☐ Faire une bronchoscopie

Vous avez pratiqué une lobectomie thyroïdienne droite chez une patiente de 55 ans en BSH pour un goitre droit (le lobe gauche est normal à l'échographie pré-opératoire). La pathologie définitive montre un microcarcinome papillaire de 3 mm en plus de nodules bénins. Quelle est la suite de la prise en charge ?

participants: 0

Options:

- ☐ Thyroïdectomie de totalisation, Euthyrox (Lévothyroxine, T4), traitement par iode radioactif
- ☐ Rien de plus pour le cancer, elle est guérie. Dosage de la TSH à 6 semaines pour s'assurer que la fonction thyroïdienne est correcte.
- ☐ Chimio-radiothérapie adjuvante
- ☐ Traitement par iode radioactif et Euthyrox (Lévothyroxine, T4)
- ☐ Thyroïdectomie de totalisation, radiothérapie adjuvante et Euthyrox (Lévothyroxine, T4)

Un jeune homme de 18 ans, non fumeur, vous consulte pour des douleurs brutales dans l'hémithorax gauche. Vous remarquez que son pouls est à peine palpable, les veines du cou sont turgescentes et vous auscultez une absence de murmure vésiculaire. Qu'est-ce que vous faites?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://www.surveymonkey.com/s/28X312>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:15:12 +0200

participants: 0 | time left: 0:41

Options:

- ☒ Vous suspectez une tamponnade cardiaque et appelez le chirurgien cardiaque et un cardiologue
- ☐ C'est certainement un pneumothorax. Vous demandez une radio du thorax
- ☐ Vous posez un drain thoracique
- ☐ Vous exsufflez avec une aiguille dans le 2ème espace intercostal. Il s'agit d'un pneumothorax sous tension.

Quelle pathologie ne peut pas entraîner de paralysie diaphragmatique ?

This survey is . People can access this survey at <https://forms.gle/351281772345272044112K-447941123>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:17:41 +0200

participants: 0 | time left: 0:47

Options:

- ☐ Un traumatisme thoracique
- ☐ Un carcinome épidermoïde ORL avec métastases ganglionnaires cervicales
- ☐ Un thymome
- ☐ Un Schwannome thoracique
- ☐ Un lymphome

Une patiente de 65 ans en BSH vous consulte pour asthénie et faiblesse musculaire. La densitométrie osseuse retrouve une ostéoporose diffuse. Le bilan biologique montre une hypercalcémie à 3.01 mmol/l et une PTH à 23.3 pmol/l (normes de 1.1 à 6.8). Suite de la prise en charge

This survey is **ENDING**. People can access this survey at <https://sango-question.de/649013>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:21:17 +0200

participants: 0 | time left: 0:42

Options:

- ☒ CT thoraco-abdo
- ☐ Scintigraphie osseuse
- ☐ Bilan génétique
- ☐ Coloscopie
- ☐ Ultrason et scintigraphie au ^{99m}Tc sestamibi

Un patient de 22 ans en BSH se présente avec une déformation importante de la paroi thoracique sous forme de pectus excavatum. Quelle proposition est correcte ?

This survey is  People can access this survey at <https://forms.gle/848221>
end of survey: Tue, 13 Jun 2024 13:24:02 +0200

participants: 0 | time left: 0:49

Options:

- ☒ A L'indication opératoire principale des déformations de la paroi thoracique est donnée par l'impact cardio-respiratoire qu'a le pectus excavatum sur les organes intrathoraciques
- ☐ B Il s'agit la plupart du temps d'une indication cosmétique uniquement
- ☐ C La plupart des patients ont également une anomalie de la racine de l'aorte
- ☐ D A, B et C sont corrects
- ☐ E A, B et C sont faux

Un patient de 22 ans, tabagique actif à 10 UPA et fumeur occasionnel de cannabis se présente aux urgences avec un pneumothorax gauche complet. Il avait déjà présenté un épisode de pneumothorax gauche traité avec succès par drainage en fin 2016. Quelle proposition est fausse ?

This survey is **running**. People can access this survey at <https://pinget.com/question/949311>

end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:27:01 +0200

participants: 0 | time left: 0:50

Options:

- ☐ Il devrait être exsufflé ou drainé aux urgences
- ☐ S'il n'arrête pas de fumer, son risque de récurrence est proche de 10%
- ☐ La plongée sous-marine est contre-indiquée chez lui
- ☐ Une thoracoscopie lui sera probablement proposée
- ☐ S'il arrête de fumer, le risque de nouvelle récurrence de pneumothorax est réduit

La prise en charge d'un traumatisé thoracique répond aux règles notamment:

This survey is open. People can access this survey at <https://forms.gle/103495272044712811861472413311>

end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:29:58 +0200

participants: 0 | time left: 0:55

Options:

- ☒ Drainage des épanchements + antalgiques + éviter les efforts de toux
- ☐ Drainage des épanchements + antalgiques + repos pour éviter les déplacements secondaires des fractures costales
- ☐ Contre-indication à l'analgésie péridurale en raison du risque hémorragique
- ☐ Aucune des propositions n'est juste

Un patient de 79 ans, ancien tabagique à 60UPA, aux antécédents d'infarctus avec PTCA et mise en place d'un stent actif sur l'IVA en 2008 vous consulte pour une masse pulmonaire du poumon gauche de 7 cm, centrale, qui prend la bronche souche gauche et dont la biopsie par bronchoscopie montre qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. Le patient n'a pas de symptômes à l'exception d'une perte de 3 kg récente. Le PET-CT ne montre pas d'autre foyer de captation que cette masse. Le VEMS est à 30% du prédit, de même que la DLCO. La scintigraphie de perfusion montre que le poumon gauche participe à 42% de la perfusion totale (G 42%, D 58%). Quelle proposition est juste ?

This survey is  People can access this survey at <https://quizlet.com/survey/3433113>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 12:22:20 +0000.

participants: 0 | time left: 0:45

Options:

- ☐ Le patient bénéficiera probablement d'une résection atypique G
- ☐ Le patient bénéficiera probablement d'une pneumonectomie G
- ☐ Le patient bénéficiera probablement d'une lobectomie supérieure gauche
- ☐ Le patient bénéficiera probablement d'une lobectomie inférieure gauche
- ☐ Le patient bénéficiera probablement d'un traitement palliatif

Vous avez pratiqué une thyroïdectomie totale chez une patiente de 40 ans en BSH pour un cancer papillaire de la thyroïde de 3 cm avec quelques adénopathies envahies, pT2N1 (3N+/7N). Le lendemain de l'intervention, la patiente se plaint de fourmillements autour de la bouche et dans les extrémités avec quelques crampes. Quelle proposition est correcte ?

This survey is **Public**. People can access this survey at 
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:38:11 +0200

Survey from Tue, 18 Jun 2024
13:37:11 +0200

participants: 0 | time left: 0:55

Options:

- ☐ La substitution thyroïdienne est probablement trop faible, vous augmentez la dose d'Euthyrox (Levothyroxine, T4)
- ☐ La substitution thyroïdienne est probablement trop forte, vous diminuez la dose d'Euthyrox (Levothyroxine, T4)
- ☐ Il s'agit probablement d'une hypocalcémie, vous débutez la substitution en calcium et Vitamine D
- ☐ La patiente est très angoissée, vous lui donnez des Benzodiazépines
- ☐ Il s'agit probablement d'un manque de Magnésium, vous lui donnez du magnésium

Un patient de 65 ans, tabagique actif à 50 UPA, avec antécédent de pontage fémoro-poplité D vous consulte pour un nodule pulmonaire spiculé de 3 cm de diamètre au centre du lobe pulmonaire supérieur droit. La bronchoscopie est normale, le PET-CT montre que ce nodule hypercapte avec un SUV max à 6.5 mais ne montre pas d'autre foyers de captation. Les fonctions pulmonaires montrent un VEMS à 85% du prédit et une DLCO à 90% du prédit. Quelle est l'étape suivante ?

This survey is  People can access this survey at <https://www.surveymonkey.com/s/6678887/212222-222222-222222>
end of survey: Tue, 15 Jun 2024 13:39:45 +0200

participants: 0 | time left: 0:52

Options:

- ☐ Une médiastinoscopie
- ☐ Une radiothérapie stéréotaxique
- ☐ Une lobectomie pulmonaire supérieure droite
- ☐ Une chimiothérapie à base de Platine (p.ex. Cisplatine + Taxotère)
- ☐ Une pneumonectomie droite

Vous avez pratiqué une lobectomie thyroïdienne droite chez une patiente de 25 ans en BSH pour un nodule thyroïdien suspect à la cytoponction. Le diagnostic pathologique final montre qu'il s'agit d'un carcinome papillaire de la thyroïde de 3.5 cm limité à la thyroïde, avec 4 ganglions envahis sur 6 prélevés, stade pT2pN1(4N+/6N). Quelle est la suite de la prise en charge ?

This survey is complete. People can access this survey at <https://forms.gle/90EE90>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:42:38 +0200

participants: 0 | time left: 0:53

Options:

- ☒ Thyroïdectomie de totalisation, Euthyrox (Lévothyroxine, T4), traitement par iode radioactif
- ☐ Rien de plus, elle est guérie
- ☐ Chimio-radiothérapie adjuvante
- ☐ Traitement par iode radioactif et Euthyrox (Lévothyroxine, T4)
- ☐ Thyroïdectomie de totalisation, radiothérapie adjuvante et Euthyrox (Lévothyroxine, T4)

Un patient de 75 ans, ancien tabagique à 50UPA, diabétique insulinorequérant vous consulte pour une masse pulmonaire du lobe inférieur droit de 6 cm dont la biopsie par bronchoscope montre qu'il s'agit d'un adénocarcinome d'origine pulmonaire. Le patient n'a pas d'autres symptômes que des céphalées d'apparition récente, quelques troubles de l'équilibre ainsi qu'une toux matinale depuis des années. Le PET-CT ne montre pas d'autre foyer de captation que cette masse. Les fonctions pulmonaires sont bonnes. Quelle est l'étape suivante ?

This survey is **closed**. People can access this survey at <https://survey.medicins.fr/868111>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:44:24 +0200

participants: 0 | time left: 0:54

Options:

- ☐ Une médiastinoscopie
- ☐ Une thoracoscopie diagnostic
- ☐ Une scintigraphie pulmonaire
- ☐ Une IRM cérébrale
- ☐ Un EBUS

Quel type de cancer pulmonaire a le comportement le plus agressif?

This survey is **running**. People can access this survey at <https://pingo.coactum.de/849531>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:46:42 +0200.

participants: 0 | time left: 0:54

Options:

- ☐ Adénocarcinome
- ☐ Carcinome à grandes cellules
- ☐ Cancer pulmonaire à petites cellules
- ☐ Carcinome épidermoïde pulmonaire
- ☐ Carcinome peu différencié

Une patiente de 25 ans en BSH présente un nodule thyroïdien droit de 2 cm suspect à la cytoponction (lésion à prédominance microfolliculaire, suspecte de néoplasie folliculaire). Vous prévoyez une lobectomie thyroïdienne droite. La laryngoscopie pré-opératoire montre une bonne mobilité des 2 cordes vocales. Quelle proposition est fausse ?

This survey is **running**. People can access this survey at <https://survey-dot-com-qa.appspot.com/269112>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:47:52 +0200

participants: 0 | time left: 0:57

Options:

- ☐ Le risque de lésion définitive du nerf récurrent est d'environ 1%
- ☐ Le risque d'hypoparathyroïdisme (hypocalcémie) transitoire est d'environ 20%
- ☐ Le risque d'hémorragie post-opératoire nécessitant une réopération en urgence est d'environ 1%
- ☐ Le risque de devoir prendre une substitution thyroïdienne en post-opératoire est d'environ 5%
- ☐ Le risque de malignité est d'environ 20%

Un patient de 30 ans, sans autre antécédent qu'une dépression se présente avec des douleurs thoraciques qui révéleront une volumineuse masse médiastinale antérieure de 7 cm de diamètre. Quelle proposition est fausse ?

This survey is **closed**. People can access this survey at [5023777214421442061067445011](#)
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:50:05 +0200

participants: 0 | time left: 0:48

Options:

- ☐ Il est nécessaire de lui examiner les testicules
- ☐ Les β -HCG et l' α -foetoprotéine devraient être dosés
- ☐ Il pourrait s'agir d'un thymome
- ☐ Il s'agit possiblement d'un Schwannome
- ☐ Une paralysie diaphragmatique pourrait être en relation avec cette masse

Dans quelle population l'incidence du cancer pulmonaire augmente le plus actuellement ?



This survey is **ENDING**. People can access this survey at <https://pingo.ocantun.de/849511>
end of survey: Tue, 18 Jun 2024 13:53:34 +0200.

participants: 0 | time left: 0:56

Options:

- ☐ Chez les personnes de plus de 80 ans
- ☐ Chez les hommes
- ☐ Chez les femmes
- ☐ Chez les habitants des villes